

# 1. Einleitung

---

Wer sind wir und was ist unser Projekt ?

Wir sind Robin Hefner und Florian Hauptmann, Masterstudierende der Medizinischen Informatik im 3. Fachsemester. Im Rahmen unseres Research Projects am Institut für Medizinische Informatik widmen wir uns der Weiterentwicklung digitaler Lehrumgebungen.

Der Kern unserer Arbeit ist die Erzeugung realistischer klinischer Daten für das Heidelberger Lehre-KIS. Da echte Patientendaten aus Datenschutzgründen nur beschränkt für die Lehre verwendet werden können, entwickeln wir eine Lösung, die täuschend echte, aber vollständig synthetische Fallverläufe generiert.

Das Ziel unserer Arbeit ist die Erzeugung realistischer klinischer Daten, die in Komplexität und Struktur echten Patientenakten in nichts nachstehen. Durch die intelligente Verknüpfung verschiedener Datenquellen und Modellierungsverfahren schaffen wir eine fundierte Datenbasis, die:

- Den klinischen Alltag realitätsgetreu abbildet.
  - Die Ausbildung angehender Mediziner und Informatiker durch praxisnahe Szenarien verbessert.
  - Eine konsistente und logische Integration von Patientenhistorien und Sensordaten ermöglicht.
- 

## 2. Hintergrund

---

Können Sie kurz Ihre Rolle und Ihre Erfahrung im Bereich (Medizininformatik, Medizin, Professur/Lehre) beschreiben ?

Welche Berührungspunkte haben Sie bisher mit synthetischen Patientendaten, Lehr-Informationssystemen oder Sensordaten ?

*Hinweis:* In den Abschnitte 3-5 sind nur die Abschnitte auszufüllen zu denen auch Erfahrung vorhanden ist. (z.B. Ein Arzt muss Abschnitt 4 nicht ausfüllen wenn er darin keine Expertise hat)

---

## 3. Medizinische Qualität

---

Was macht medizinische Patientendaten aus medizinischer Sicht "glaubwürdig" ?

- zeitliche Verläufe
- Lebendigkeit der Daten

Wie wichtig ist die longitudinale Konsistenz ?

Welche Rolle spielen Komorbiditäten bei der Synthese ?

- Wie häufig sollen sie Vorkommen ?

In welcher Granularität sollten Sensordaten in einem Patientendashboard angezeigt werden ?

---

## 4. Informationstechnische Qualität

---

Welche Rolle spielen Interoperabilitätsstandards wie HL7 FHIR bei der Bereitstellung dieser Daten ?

Welche Anforderungen gibt es an die Skalierbarkeit ?

- Wie wichtig ist die Generierung von Datensätzen die in die 1000 bis 10.000 gehen
- 

## 5. Didaktische Qualität

---

Wie muss die Komplexität der Daten an das Vorwissen der Studierenden angepasst werden ?

Welche Dinge wären für eine gute Didaktische Qualität wichtig ?

Welche Informationen sollte man aus didaktischer Sicht in einem Patientendashboard anzeigen ?

---

## 6. Abschluss

---

Gibt es aus Ihrer Sicht einen kritischen Aspekt den wir bisher übersehen haben ?

Hier ist zudem Platz weitere Anmerkungen/Input einzubringen, der ggf. nicht durch Fragen abgedeckt wurde.